

浅谈药物相互作用

白 椿 高 峰

(包头市第七医院)

近年来由于药物的配伍不当造成的药源性疾病的资料时有报导。为此建议我们的药剂人员更全面的了解药物相互作用所产生的不良后果积极地临床提供安全有效的合理用药途径。以下列出药物相互作用的实例可供参考。

青霉素与氯霉素或四环素合用,在肺炎双球菌性脑膜炎中或在溶血性链球菌所致的咽喉炎中,以两类药物同用,会导致疗效降低,因氯霉素和四环素均为抑菌性抗生素会干扰青霉素的杀菌作用。

庆大霉素与氨茶碱配伍,前者可使后者的毒性反应增加,两药合用呈酸碱配伍禁忌,产生混浊和沉淀。庆大霉素在碱性中作用增强,相应对前庭神经的毒性也增加,合用会产生庆大霉素的中毒反应。

维生素 C 与碳酸氢钠配伍,维生素 C 易被氧化而破坏,维生素 C 为酸性药物(PH=4.5-6)在碱性溶液中更易被破坏

生成太罗酸和草酸而失去原有的药理作用。

胃酶与碳酸氢钠,后者(PH=8.5)能中和胃酸使胃液 PH 提高而使胃酶的活性降低,胃酶的 PH 在 2 时,活性最大。

氨茶碱与潘生丁,二者呈拮抗作用,二者的拮抗可与腺甙有关,即前者可直接拮抗腺甙对平滑肌的松弛作用,以致使后者无从发挥扩冠作用,二者不宜合用。

氨茶碱与毒 K 合用,易导致毒 K 失效,后者为碱性药物,是茶碱乙二胺的复盐,毒 K(PH=5.5)在碱性中易水解而失效。

消炎痛与心得安,二者呈拮抗作用,消炎痛抑制前列腺素的合成,使血压升高, β 受体阻滞剂可刺激前列腺素的合成,使血压降低两者互相拮抗。

(收稿 1994-01-10)

碘过敏患者 1 例抢救体会

张风凤 王文清

(包头市第二医院)

患者,女,38 岁。因反复发作性右上腹疼痛,伴皮肤及巩膜黄染而诊断为胆总管结石收入院。完善各项检查后,行胆囊切除、胆总管探查、T 型管引流加腹腔引流术,术后患者生命体征平稳,2 天后将腹腔引流管拔掉。T 型管引流呈胆汁样,逐日减少,20 天后,将 T 型管暂闭 3 天,未出现后背憋胀、黄染等症状,遵医嘱做碘过敏试验,按常规静脉法碘过敏试验阴性后,将 30%胆影葡胺 40 毫升另 10%葡萄糖 40 毫升,从 T 型管注入,5 分钟注射完毕,行 T 型管造影。10 分钟后,病人全身皮肤出现荨麻疹,瘙痒、面部绯红,眼睑红肿,流泪、怕光、头痛。半小时后,出现呼吸急促,口唇发绀,测血压 10/6kpa,心率快,124 次

/分,即肌肉注射非那根 25 毫克,安定 10 毫克,皮下注射盐酸肾上腺素 1 毫克,建立静脉通道,静滴 10%葡萄糖 50 毫升,地塞米松 10 毫克,维生素 C2 克,同时给氧气吸入,10 分钟后,测血压为 16/9kpa,心率为 100 次/分,缺氧症状缓解,观察 10 天,自觉症状消失,恢复正常。

分析 1、静脉法碘过敏试验,也可出现假阴性,临床上虽然少见,但亦不能麻痹大意,故造影时,应严密观察病情。2、护士应熟练掌握过敏反应的应急措施,发生病情变化,不失治疗和抢救时机,在医生不在场的情况下,果断地进行对症治疗,为抢救工作赢得时间,并及时报告医生。

(收稿:1994-1-15)